

Fecha Última Actualización: 01-03-2022 0:16:58

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Ana Luisa Arevalo Arias

Edad : 59a 5m 21d

Dirección : C/26 De Enero 1130 V/Bdo Leighthon

Rut : 8.117.797-K

Fecha Nacto: 08/09/1962

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1007573

Sexo : Femenino

Teléfono : 9 3638 6905

N° Epicrisis

297680

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Cuidados Básicos 5° Piso

Fecha Ingreso : 03/02/2022 14:10

Días Estadía: 26

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 01/03/2022 00:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Shock

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Epicrisis

NOMBRE: Ana Luisa Arévalo Arias

RUT: 8117797-K

EDAD: 59 años

FECHA DE INGRESO HSR: 03/02/2022

FECHA DE INGRESO SALA: 04/02/2022

FECHA DE INGRESO UTIM: 11/02/2022

FECHA DE INGRESO UCI: 18/02/2022

ANTECEDENTES:

·Mórbidos: DHC por OH Child B/MELD 13 (VE incipientes, sin HDA, EH resuelta, Ascitis grado I-II), anemia ferropriva, pólipos colónicos, enfermedad hemorroidal, colelitiasis.

·Quirúrgicos: apendicectomía

·Fármacos: Espironolactona 100 mg/día, lactulosa 20 cc/día, propranolol 40 cada 8hrs, quetiapina 100 mg noche, alprazolam 25 mcg noche, omeprazol 20 mg /día.

·Alergias: fenitoína

·Hábitos: TBQ (+, social), OH (+, crónico, actualmente consumo social), otras drogas (-)

·Hospitalizaciones: 22/01-24/01 visita a urgencia en contexto de bradipsiquia ocasional, inestabilidad de marcha, coluria y dolor abdominal con alta voluntaria

·Social: Vive con hija. Contacto Barbara Pino (hija) 964519867. Autovalente

·Inmunizaciones: Sin vacuna covid, vacuna VHB (+)

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes descritos, es derivada a SU desde poli de gastroenterología en CDT en contexto de ictericia de 1 mes de evolución que inicia 1 semana post consumo de alcohol en navidad y año nuevo (1/4 copa de vino según lo referido por la paciente).

A la anamnesis dirigida la paciente refiere náuseas, vómitos biliosos, insomnio de conciliación, problemas de memoria y coluria. Niega dolor abdominal, fiebre, síntomas urinarios, síntomas respiratorios, diarrea o exteriorización de sangre.

Ingresa hemodinámicamente estable, afebril (36.5°), normotensa (111/63), normocárdica (78), sin requerimientos de oxígeno. Al

Fecha Epicrisis : 01/03/2022 00:16

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:22

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

examen físico se describe vigil, atenta y orientada, con ictericia en piel y escleras. MP (+), SRA, RR2T SS. Destaca abdomen globulosos, con RHA (+), sin signos de irritación peritoneal, sin matidez desplazable. EEL con leve edema.

Al ingreso se le toman exámenes donde destaca INR 1.86, Alb 2.8 BT 11, BD 7.5 FA 196 GGT 366, GOT 146 GPT 85, crea 0.85, PCR 37 y ELP 135/4.04. Además se realiza ecoscopia que no muestra líquido libre.

En este contexto se decide ingreso a medicina para manejo y estudio.

EVOLUCIÓN EN SALA DE MEDICINA

1.Hemodinamia: al ingreso estable. El 11/02 hipotensiva en contexto de descarga séptica. Lactato 29. Siempre normocárdica. En sala se volemizó con albúmina 20% + 1L de SRL. Al traslado, buena perfusión clínica.

2.Respiratorio: requerimientos de O2 en relación a shock séptico. Se realizó Rx Tx, impresiona NAAS basal derecha. Al traslado, MV 35%.

3.Infectológico: 09/02 inicia deposiciones diarreicas sin signos patológicos en hasta 10 ocasiones en 2 días, de cuantía moderada, que luego ceden espontáneamente, por lo que no se pudo realizar examen de CD. 11/02 febril 39°C, SatO2 91%, compromiso de conciencia cuantitativo. Se interpreta como sepsis, se cultiva, (HC, OC+UC, PCR COVID), se inicia Imipenem de forma empírica, sin claro foco clínico, y se volemiza. En Rx Tx impresiona foco LID, y PCR COVID-19 resulta (+).

4.Gastroenterológico/hepático: DHC descompensado child B que ingresa derivada por gastroenterología, por hiperbili de etiología no identificada. Tiene historia de consumo de OH hace más de 1 mes, con pruebas hepáticas no compatibles con hepatitis alcohólica aguda. Del estudio:

a.VE: antecedente de VE incipiente en EDA 2020, no visibles en EDA 2021. Sin sangrado durante hosp.

b.EH: se suspendió lactulosa por diarrea y luego sepsis. Actualmente no impresiona encefalópata

c.Ascitis: leve ascitis. Sin estudio de PBE por ecoscopia sin bolsillo.

d.HCC: RMN abd 06/02: No se demostraron lesiones focales que cumplan criterios de hepatocarcinoma.

e.OH: Impresiona hepatitis alcohólica leve, en contexto de discreta alteraciones de transaminasas GOT/GPT cercano a 2, GGT discreta elevación. Con Maddrey bajo al ingreso, se desestima uso de corticoides. Posteriormente caída franca de bilirrubina.

SHR: AKI de probable origen prerrenal, dado aumento de pérdidas gastrointestinales. Se inició volemización con albúmina, con adecuada respuesta.

Se solicitaron serologías de autoinmunidad como ampliación de estudio de progresión de DHC. IgA, IgG e IgM elevadas. ANA, AMA y ASMA negativos.

5.Nefrológico: AKI de probable origen prerrenal, dado aumento de pérdidas gastrointestinales. Se inició volemización con albúmina. Hiponatremia moderada de 129, sin otras alteraciones electrolíticas. 11/02 volemización con cristaloides y albúmina por sepsis, Crea estacionaria.

Paciente evoluciona con deterioro hemodinámico y ventilatorio en contexto de shock séptico por lo que se traslada a unidad de intermedio el 11/02/2022.

Evolucion en UTI

Hemodinamia: a su ingreso con tendencia a la hipotension que recupera tras volemizacion con cristaloides y cristaloides. Evolucion favorable hasta el 17/02 donde evoluciona con hipotension en relacion a induccion preintubacion, por lo que se instala CVC e inicia noradrenalina en dosis bajas. Sin evidencias de sangrado ni necesidad de transfusion durante estadia en UTI.

Respiratorio: a su ingreso a la unidad con requerimientos de CNAF que se mantienen constantes durante estadia. Rx TX del 11/02 con infiltrado perihiliar derecho, que se hace bilateral en Rx Tx del 17/02. PCR COVID (+) (previa del 03/02/22 negativa). Se inicia manejo como Neumonía COVID19, con insuficiencia respiratoria aguda severa, con buena respuesta inicial. El 17/02 se describe deterioro progresivo de mecanica ventilatoria y caída de PAFI hasta 107, por lo que se intuba y conecta a VMI. Dado PAFI de control en 75 se decide inicio de BNM. Se traslada a UCI para continuar VMI y manejo.

Infeccioso: sepsis intrahospitalaria, del estudio realizado el 11/02 se aísla: PCR COVID19 (+) y HCs + UC (+) KPN MS. Tras identificación de germen y sensibilidad microbiológica se rota de imipenem a ceftriaxona, con buena respuesta clínica y de laboratorio. Actualmente en día 7 de terapia ATB y esteroidal.

Gastrointestinal: DHC Child-B de etiología OH (ya estudiado el 2016 y se repite estudio negativo HAI/viral actual).

Ingresa derivada desde Gastroenterología CDT para estudio de Hiperbilirrubinemia, a su ingreso con patrón más bien mixto, GGT 366, GOT>GPT (no en relación 2:1) y antecedente de consumo OH (ocasional, social, 1 copa según paciente y familia), colangioRNM sin evidencia de litiasis, ha evolucionado con enzimas y BiliT a la baja (11.7 ¿ 5.59).

Fecha Última Actualización: 01-03-2022 0:16:58

Página 3 de 4

Además, con DHC descompensado, por planes:

- EH: se retiró lactulosa por diarrea y sepsis, reincide EH por lo que ayer, se reinicia, titulando, EH grado I.
- VE: incipientes en EDA del 2020, no evidenciadas en EDA del 2021, agendar para este año.
- Ascitis: grado I sin bolsillo puncionable, usuaria de Espiro 100mg (retirada por sepsis, reiniciar en días a seguir).
- PBE: sin bolsillo puncionable para estudio.
- HCC: RNM actual sin lesiones focales hepáticas visibles.
- SHR: sin evidencia de SHR, curso AKI que bien se traduce por sepsis/pérdidas gastrointestinales, resuelta.

Renal/medio interno: Cursó AKI en contexto de sepsis/diarrea, que se resuelve tras control de patología aguda.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UCI

- 1.- Insuficiencia respiratoria aguda
 - NAAS
 - COVID 19
- 2.Sepsis foco pulmonar/urinario en tto
 - a.NAC COVID-19
 - i.FIS 10/02; día +7
 - ii.NO VACUNADA
 - iii.Obs sobreinfección bacteriana
- IV. PNA aguda
- 3.DHC descompensado Meld 23 en estudio
 - a.EH Grado I-II - resuelta
 - b.VE (sin varices referidas en EDA 2021), actualmente sin sospecha de sangrado
 - c.Ascitis grado I
 - d.Lesiones hepáticas quísticas
- 4.Hiperbilirrubinemia de predominio directo en estudio
 - a.Obs progresión de DHC conocido vs hepatitis OH
 - b.Colelitiasis
- 5.Angiomiolipoma renal izquierdo
- 6.Antecedentes: Pólipos colónicos, enfermedad hemorroidal, colelitiasis.

Evolucion en UCI.

Paciente ingresa por falla respiratoria por COVID-19 asociado a co-infección de PNA Bacterémica a K. Pneumoniae. Completa 10 días de Ceftriaxona con buena respuesta infectológica.

En lo ventilatorio, con lenta pero aceptable mejoría, llegó a estar en plan de weaning por 48 horas. Sin embargo no se pudo progresar por Encefalopatía Hepática importante.

Hace 48 horas evoluciona con nuevo hit infeccioso y Shock séptico refractario 2ario a Bacteremia a K. Pneumoniae con sensibilidad que se mantiene pendiente. Se realizó reanimación con volumen, DVA y cobertura con Imipenem+Vancomicina.

Evoluciona con Shock séptico refractario a medidas, progresión de falla renal y reagudización de DHC.

Se constata fallecimiento a las 00:05 am.

Diagnóstico de Egreso

Shock septico - Bacteriemia por KPN
Insuficiencia Renal Aguda - 2ario a COVID-19
Insuficiencia Renal Aguda -
Insuficiencia hepática aguda - Sobre DHC avanzado

Condición de Egreso

Fallecida

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Fecha Epicrisis : 01/03/2022 00:16

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:22

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Daniel Sánchez Sobarzo

Médico Tratante (Staff)